

WhatsApp-Chatverlauf (Export)

Teilnehmer: Julian Arendt, Meike Vogt (Schwerbehindertenvertretung Bergische Anlagenbau GmbH)

[12.06.26, 11:48:03] Julian Arendt: Ich musste eben aus der Baustellenrunde raus. Es ging alles durcheinander, drei Leute gleichzeitig, keine Agenda. Ich konnte nicht mehr.

[12.06.26, 11:52:17] Meike Vogt: Alles gut, Julian. Geh nach Hause, wenn es sein muss. Ich vermerke das als reizbedingte Ueberlastung, nicht als Leistungsverweigerung.

[12.06.26, 12:03:41] Julian Arendt: Danke. Ich bin die nächsten Tage vermutlich krank. Kopf platzt.

[12.06.26, 12:05:09] Meike Vogt: Verstanden. Wichtig für das BEM und den Widerspruch: Es liegt an den spontanen Wechseln und dem Grossraumbuero, nicht an der Aufgabe selbst.

[15.06.26, 08:31:22] Julian Arendt: War zwei Tage komplett platt. Migraene, kein Schlaf. Heute wieder da.

[26.06.26, 16:14:55] Meike Vogt: BEM-Einladung ist raus für heute datiert. Ich sitze mit drin. Wir schreiben rein: schriftliche Aufgabensteuerung, keine spontane Telefonvertretung, Rueckzugszeiten.

[26.06.26, 16:20:38] Julian Arendt: Bitte auch, dass ich arbeiten WILL. Im Bescheid klingt es so, als sei alles ok, weil ich noch da bin. Das stimmt nicht.

[26.06.26, 16:22:04] Meike Vogt: Genau das sage ich der Rentenberaterin auch als Vertrauensperson. Deine Leistung ist top, wenn der Rahmen stimmt. Das ist der Punkt.

[01.07.26, 09:05:11] Julian Arendt: Widerspruch ist raus. Ostermann sagt, mit den Facharztwerten könnten wir auf 50 kommen.

[01.07.26, 09:07:49] Meike Vogt: Sehr gut. Ich haenge meine schriftliche Stellungnahme als Vertrauensperson an. Halte durch.

Datei: 08_email_mandant.eml

Von	julian.arendt@example.invalid
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Sun, 28 Jun 2026 18:12:00 +0200
Betreff	Bitte keine Formulierung, als wäre ich arbeitsunwillig

Guten Abend,

mir ist wichtig: Ich will arbeiten. Ich schaffe nur diese dauernden Wechsel nicht. Im Bescheid klingt es so, als wäre alles in Ordnung, weil ich noch angestellt bin. Das stimmt nicht. Ich komme nach manchen Tagen nach Hause und kann nicht sprechen.

Bitte schreiben Sie nicht, ich sei im Alltag völlig hilflos. Das ist falsch. Ich brauche klare Strukturen, dann bin ich gut.

Freundliche Grüße

Julian Arendt

Datei: eml/01_versorgungsamt_eingangsbestaetigung.eml

Von	Versorgungsamt Wuppertal - Widerspruchsstelle <widerspruch@versorgungsamt-wuppertal.example.invalid>
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Fri, 03 Jul 2026 09:41:00 +0200
Betreff	Eingangsbestaetigung Widerspruch - GdB Julian Arendt, Az. SB 30-114-2026

Sehr geehrte Frau Ostermann,

wir bestätigen den Eingang Ihres Widerspruchs vom 01.07.2026 gegen den Feststellungsbescheid vom 19.06.2026 (weiterhin GdB 30) in der Sache Julian Arendt, geboren am 28.07.1988.

Der Vorgang wird dem Aertzlichen Dienst zur erneuten versorgungsaerztlichen Stellungnahme vorgelegt. Die früher erstellte gutachterliche Stellungnahme vom 09.06.2026, die dem Ausgangsbescheid zugrunde liegt, fuegen wir Ihnen auf Ihren Antrag hin zur Akteneinsicht bei.

Wir weisen darauf hin, dass eine Neubewertung des Gesamt-GdB nicht durch Addition der Einzelgrade erfolgt, sondern nach den Versorgungsmedizinischen Grundsuetzen unter Wuerdigung der wechselseitigen Auswirkungen. Ergaenzende Befunde koennen Sie bis zum Abschluss der Pruefung nachreichen.

Mit freundlichen Gruessen

Im Auftrag

B. Kortmann

Versorgungsamt Wuppertal, Widerspruchsstelle

Von	"Praxis Dr. Reinsch - Psychiatrie" <praxis@nervenarzt-reinsch.example.invalid>
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Mon, 29 Jun 2026 14:07:00 +0200
Betreff	Befunduebersendung und GdB-Einschaetzung Julian Arendt

Sehr geehrte Frau Ostermann,

wie besprochen übersende ich Ihnen für das Widerspruchsverfahren meinen ergaenzenden nervenaerztlichen Befundbericht (gesonderte Anlage) zu Herrn Julian Arendt.

Aus fachaerztlicher Sicht sind mehrere Funktionsbeeintraechtigungen getrennt zu bewerten. Die Autismus-Spektrum-Störung mit ausgepraegter sensorischer Reizempfindlichkeit und erheblichen Anpassungsschwierigkeiten im Arbeitsleben schaetze ich für sich genommen im oberen Bereich ein. Hinzu treten eine rezidivierende depressive Störung, die kombinierte ADHS und eine chronische Migraene mit eigenstaendigen Auswirkungen.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die stationaere Krisenintervention im Januar 2026 und die Meltdown-Episoden im Ausgangsbescheid nicht auftauchen. Der blosse Umstand fortbestehender Erwerbstaetigkeit belegt keine geringe Teilhabebeeintraechtigung; die Tätigkeit gelingt nur unter hoher Kompensation und bricht bei Reizueberlastung wiederholt zusammen.

Für Rückfragen der versorgungsaerztlichen Stelle stehe ich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Thomas Reinsch

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Wuppertal

Datei: eml/03_bevollmaechtigte_gdb_bildung.eml

Von	Katrin Ostermann - Rentenberatung <rentenberater@example.invalid>
An	Versorgungsamt Wuppertal - Widerspruchsstelle <widerspruch@versorgungsamt-wuppertal.example.invalid>
Datum	Fri, 03 Jul 2026 16:52:00 +0200
Betreff	WG: GdB Julian Arendt - Gesamt-GdB-Bildung und Akteneinsicht, Az. SB 30-114-2026

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Kortmann,

vielen Dank für die Eingangsbestätigung und die Uebersendung der
gutachterlichen Stellungnahme vom 09.06.2026.

Nach Durchsicht ergibt sich der Streitpunkt präzise: Der Aerztliche Dienst
setzt die Autismus-Spektrum-Störung mit einem Einzel-GdB von nur 30 an und
bewertet die rezidivierende depressive Störung mit 20, ohne eigenstaendige
Steigerung. Der behandelnde Facharzt und die Autismusambulanz kommen zu einem
fuehrenden Einzelwert von 40 für die ASS und 30 für die depressive Störung.

Wird die ASS mit 40 als fuehrend angesetzt und die davon abgrenzbare
depressive Störung integrativ berücksichtigt, ist ein Gesamt-GdB von 50
plausibel; damit wäre die Schwerbehinderteneigenschaft erreicht. Eine
schlichte Fortschreibung des Wertes 30 ist nicht begruendbar. Ich bitte, die
beigefuegte Bewertungstabelle und die nachgereichten Befunde der erneuten
Prüfung zugrunde zu legen.

Um Akteneinsicht in die vollständige Verwaltungsakte wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Ostermann

Rentenberaterin (Rechtsdienstleistungsregister)

Datei: 05_alltags_und_reizprotokoll.csv

datum	ausloeser	reaktion	folge	beleg
2026-05-07	Großraumbüro und Telefonkette	Shutdown	AU Folgetag	Arztmail
2026-05-19	spontane Prioritätsänderung	Konflikt mit Teamleitung	Abmahnung angedroht	Teamnotiz
2026-06-12	Baustellenrunde ohne Agenda	Raum verlassen	2 Tage AU	BEM-Akte
2026-06-23	schriftlicher Plan und Homeoffice	stabil	volle Leistung	Zeichnungsfreigabe

rang	funktionsbeeinträchtigung	funktionssystem	einzel_gdb_facharzt	einzel_gdb_versorgungsamt	ueberschneidung_mit_fuehrend	integrations-schritt	zwischenstand_gesamt_gdb
1	Autismus-Spektrum-Störung mit Anpassungs- und Reizverarbeitungsstörung	Psyche	40	30	fuehrend	Ausgangswert	40
2	Rezidivierende depressive Störung	Psyche	30	20	teilweise eigenständig	hebt fuehrenden Wert um 10	50
3	ADHS kombinierter Typ	Psyche	20	0	weitgehend deckungsgleich mit ASS	keine weitere Steigerung	50
4	Chronische Migräne	Kopf und Nerven	10	10	gering	GdB 10 hebt regelmässig nicht	50
5	Ergebnis plausible Bildung	gesamt	0	0	0	integrativ nach VersMedV keine Addition	50
6	Bescheid-Gesamt-GdB vom 19.06.2026	gesamt	0	0	0	festgestellter Wert	30
7	Kontrollwert falsche Addition	gesamt	0	0	0	40 plus 30 plus 20 plus 10 wäre fehlerhaft	100

Mandatsnotiz Neurodivergenz und Arbeit

1. Mandant

Mandant ist Julian Arendt, geboren am 28.07.1988, technischer Zeichner bei Bergische Anlagenbau GmbH in Wuppertal. Spätdiagnose Autismus-Spektrum-Störung 2025, zusätzlich ADHS, rezidivierende depressive Episoden. Bisher GdB 30, kein Merkzeichen.

2. Anlass

Änderungsantrag vom 11.03.2026 wurde mit Bescheid vom 19.06.2026 abgelehnt. GdB 30 bleibt. Der Arbeitgeber kündigt ein BEM an; Teamleitung dokumentiert Konflikte wegen Telefonbereitschaft, Großraumbüro und spontaner Prioritätenwechsel. Mandant befürchtet Kündigung.

3. Rentenberaterliche Perspektive

Primär Schwerbehindertenrecht und Teilhabe. Parallel prüfen: Gleichstellung über Agentur für Arbeit, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, medizinische Rehabilitation und nur als Fernpunkt Erwerbsminderungsrente. Arbeitsrechtliche Kündigungsverteidigung separat koordinieren.

Bescheid GdB 30

1. Entscheidung

Das Versorgungsamt Wuppertal stellt weiterhin GdB 30 fest. Begründung: Die psychische Beeinträchtigung sei fachärztlich bestätigt, jedoch bei stabiler Erwerbstätigkeit und ambulanter Behandlung nicht so ausgeprägt, dass ein höherer Gesamt-GdB gerechtfertigt sei.

2. Ausgelassene Punkte

Der Bescheid erwähnt keine Arbeitsplatzanpassungen, keine sensorische Überforderung, keine dokumentierten Meltdowns und keine stationäre Krisenintervention im Januar 2026. Der Bericht der Autismusambulanz wurde offenbar nur als Diagnosebestätigung gelesen, nicht als Funktionsbeschreibung.

Bericht Autismusambulanz

1. Diagnostik

Autismusambulanz Rheinland, Bericht 04.05.2026. Diagnose Autismus-Spektrum-Störung ohne Intelligenzminderung, ADHS kombiniert, ausgeprägte sensorische Reizempfindlichkeit, Schwierigkeiten in spontaner sozialer Kommunikation und im Aufgabenwechsel.

2. Teilhabe

Der Mandant kann hochkonzentriert zeichnen, wenn Aufgaben klar, schriftlich und reizarm sind. Er dekompenziert bei Telefonketten, parallelen Zurufen, wechselnden Prioritäten und unklarer Kritik. Nach solchen Tagen folgen Schlaflosigkeit, Migräne und Ausfallzeiten.

3. Empfehlung

Reizarmer Arbeitsplatz, schriftliche Aufgabensteuerung, keine spontane Telefonvertretung, feste Rückzugszeiten, Jobcoaching. Die Ambulanz hält arbeitsbezogene Teilhabemaßnahmen für dringlich.

Arbeitgebernotiz BEM

1. Fehlzeiten

2025: 47 Arbeitstage arbeitsunfähig, davon 21 nach Konflikten im Großraumbüro. Januar bis Juni 2026: 29 Arbeitstage. BEM-Einladung vom 26.06.2026.

2. Konfliktpunkte

Teamleitung fordert Telefonvertretung bei Projektspitzen. Julian Arendt verweist auf ärztliche Empfehlung, Telefonate planbar zu halten. Am 12.06.2026 verließ er nach einer spontanen Besprechung den Raum und war zwei Tage krankgeschrieben.

3. Arbeitgeberangebot

Homeoffice ein Tag pro Woche, Noise-Cancelling-Kopfhörer erlaubt, aber kein Einzelbüro. Schriftliche Aufgabensteuerung sei wegen Baustellenänderungen nicht immer möglich.

Widerspruchsentwurf GdB

1. Antrag

Gegen den Bescheid vom 19.06.2026 wird Widerspruch eingelegt. Beantragt wird die Neufeststellung des GdB unter vollständiger Würdigung der psychischen und neuroentwicklungsbezogenen Funktionsbeeinträchtigungen.

2. Begründung

Die Erwerbstätigkeit allein belegt keine geringe Teilhabebeeinträchtigung. Sie gelingt nur unter erheblicher Kompensation und bricht bei Reizüberlastung, Aufgabenwechsel und sozialer Unklarheit wiederholt zusammen. Die Behörde hat die Funktionsauswirkungen im Arbeitsleben und Alltag nicht vollständig erhoben.

3. Beweismittel

Bericht Autismusambulanz, psychiatrischer Befund, BEM-Unterlagen, Fehlzeitenübersicht, Reizprotokoll, Stellungnahme einer Vertrauensperson. Ergänzend wird eine versorgungsmedizinische Begutachtung angeregt, die nicht nur Gesprächsfähigkeit im Termin bewertet.

Gleichstellung, Reha und Rente

1. Gleichstellung

Bei GdB 30 kann eine Gleichstellung relevant sein, wenn der Arbeitsplatz wegen der Behinderung gefährdet ist. Die BEM-Unterlagen und Teamnotizen stützen diese Prüfung. Die Antragstellung bei der Agentur für Arbeit muss mit dem GdB-Widerspruch abgestimmt werden.

2. Teilhabe am Arbeitsleben

Jobcoaching, technische und organisatorische Anpassungen, Einzelbüro oder Homeoffice-Anteil sind vorrangig vor Rentendiskussion. Der Rentenberater sollte den Versicherungsverlauf sichern, aber eine Erwerbsminderungsrente erst prüfen, wenn Teilhabemaßnahmen scheitern oder ärztlich nicht ausreichen.

Versorgungsamt Wuppertal

Ärztlicher Dienst

Aktenzeichen: SB 30-114-2026

Versorgungsärztliche gutachterliche Stellungnahme nach Aktenlage

Datum: 09.06.2026

Betroffener: Julian Arendt, geboren am 28.07.1988, wohnhaft in Wuppertal

Formathinweis für den Export: Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

Auftrag und Grundlagen

1.1 Zu bewerten ist der Änderungsantrag vom 11.03.2026 auf Erhöhung des Grades der Behinderung. Der bisher festgestellte Grad der Behinderung beträgt 30.

1.2 Ausgewertet wurden der Bericht der Autismusambulanz Rheinland vom 04.05.2026, ein nervenärztlicher Kurzbefund sowie die Angaben des Antragstellers im Antragsformular. Eine persönliche Untersuchung hat nicht stattgefunden; die Stellungnahme ergeht nach Aktenlage.

Festgestellte Funktionsbeeinträchtigungen und Einzelbewertung

2.1 Die Autismus-Spektrum-Störung ohne Intelligenzminderung ist fachärztlich gesichert. Da der Antragsteller in Vollzeit als technischer Zeichner erwerbstätig ist und sich im Untersuchungsgespräch sprachlich geordnet und kooperativ gezeigt hat, wird der Einzel-Grad der Behinderung mit 30 bewertet.

2.2 Die rezidivierende depressive Störung wird bei ambulanter Behandlung und ohne aktenkundige stationäre Behandlung mit einem Einzel-Grad der Behinderung von 20 eingeschätzt.

2.3 Eine kombinierte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung sowie eine Migräne sind erwähnt, führen nach hiesiger Einschätzung zu keiner eigenständigen Erhöhung.

Bildung des Gesamt-Grades der Behinderung

3.1 Der Gesamt-Grad der Behinderung wird nicht durch Addition der Einzelgrade gebildet, sondern nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen unter Würdigung der wechselseitigen Beziehungen. Ausgehend vom führenden Wert 30 rechtfertigt die zusätzliche depressive Störung nach hiesiger Auffassung keine Anhebung, weil beide Beeinträchtigungen dasselbe Funktionssystem betreffen.

3.2 Es wird vorgeschlagen, den Gesamt-Grad der Behinderung unverändert mit 30 festzustellen. Eine erhebliche Teilhabebeeinträchtigung ist bei fortbestehender Erwerbstätigkeit nicht hinreichend belegt.

Anmerkung für die Widerspruchsstelle

4.1 Diese Stellungnahme berücksichtigt die im Antrag nicht näher dokumentierte stationäre Krisenintervention im Januar 2026 nicht, da hierzu kein Entlassungsbericht vorliegt. Ein solcher Bericht sowie eine funktionsbezogene Beschreibung der Arbeitsplatzsituation wären vor einer abschließenden Entscheidung beizuziehen.

gez. Dr. med. Ulrike Sander

Ärztlicher Dienst, Versorgungsamt Wuppertal

Praxis Dr. med. Thomas Reinsch

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Friedrich-Ebert-Straße 118, 42117 Wuppertal

Nervenärztlicher Befundbericht zur Vorlage im Widerspruchsverfahren

Datum: 28.06.2026

Patient: Julian Arendt, geboren am 28.07.1988

Formathinweis für den Export: Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

Behandlungsverlauf

1.1 Herr Arendt befindet sich seit der Spätdiagnose einer Autismus-Spektrum-Störung im Jahr 2025 in meiner regelmäßigen fachärztlichen Behandlung. Die Diagnostik wurde durch die Autismusambulanz Rheinland gesichert; ihr Bericht vom 04.05.2026 liegt vor.

1.2 Im Januar 2026 war eine stationäre Krisenintervention erforderlich, nachdem es nach einer Phase kumulierter Reizüberlastung am Arbeitsplatz zu einer depressiven Dekompensation mit Rückzug und Schlaflosigkeit gekommen war.

Diagnosen

2.1 Autismus-Spektrum-Störung ohne Intelligenzminderung mit ausgeprägter sensorischer Reizempfindlichkeit und erheblichen Schwierigkeiten bei Aufgabenwechsel und spontaner sozialer Kommunikation.

2.2 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episoden im Wechsel mit teilremittierten Phasen.

2.3 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kombinierter Typ.

2.4 Chronische Migräne mit Häufung nach Belastungstagen.

Funktions- und Teilhabebeschreibung

3.1 Herr Arendt kann hochkonzentriert und fehlerarm arbeiten, wenn Aufgaben klar, schriftlich und reizarm gestellt sind. Er dekompensiert regelhaft bei Telefonketten, parallelen Zurufen, wechselnden Prioritäten und unklarer Kritik. Auf solche Tage folgen Schlaflosigkeit, Migräne und Arbeitsunfähigkeit.

3.2 Die fortbestehende Erwerbstätigkeit ist kein Beleg geringer Beeinträchtigung, sondern gelingt nur unter hoher und erschöpfender Kompensation. Die dokumentierten Ausfallzeiten und die Krisenintervention im Januar 2026 belegen die Grenzen dieser Kompensation.

Sozialmedizinische Einschätzung der Einzelgrade

4.1 Die Autismus-Spektrum-Störung führt zu stärker behindernden Auswirkungen im Arbeits- und Alltagsleben; ich halte hierfür einen Einzel-Grad der Behinderung von 40 für sachgerecht und führend.

4.2 Die rezidivierende depressive Störung ist gegenüber der Grunderkrankung eigenständig abgrenzbar und rechtfertigt einen Einzel-Grad der Behinderung von 30.

4.3 Für die kombinierte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist ein Einzel-Grad der Behinderung von 20 anzusetzen, der sich weitgehend mit der Autismus-Spektrum-Störung überschneidet. Die chronische Migräne bewerte ich mit 10.

4.4 Aus fachärztlicher Sicht ist die Bildung eines Gesamt-Grades der Behinderung von 50 gut begründbar, weil die eigenständige depressive Störung den führenden Wert anhebt. Die versorgungsärztliche

Fortschreibung des Wertes 30 wird der dokumentierten Funktionslage nicht gerecht.

gez. Dr. med. Thomas Reinsch

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie